

Espirometria SBPT 2024

FEV₁

LIN no lugar de cortes fixos, equações brasileiras, gravidade em % do previsto e novo critério de resposta ao broncodilatador.

Equações nacionais

Preferir os previstos brasileiros à GLI 2012, que tem LIN da VEF1/CVF menor e subdiagnostica obstrução.

Normalidade pelo LIN

Limite inferior = 5º percentil (escore Z -1,645). 80% do previsto fixo é simplificação ultrapassada.

Gravidade em % do previsto

Mantidos os pontos de corte da SBPT 2002: VEF1 no obstrutivo, CVF no restritivo.

Resposta ao BD

Ganho de VEF1 ou CVF em % do previsto: ≥7% se exame alterado, ≥10% se normal.

Antes de interpretar: qualidade do teste

Pelo menos três curvas aceitáveis, com repetibilidade. Volume retroextrapolado até 100 mL (ou 5% da CVF, o que for maior). Testes de baixa qualidade devem ser laudados com a incerteza explícita; valores próximos ao LIN pedem correlação com a probabilidade pré-teste (questionário respiratório).

Algoritmo de interpretação

Figura 4 da diretriz, resumida

- 1

VEF1/CVF pré-BD < LIN define distúrbio ventilatório obstrutivo (DVO). Não usar 0,70 fixo: subdiagnostica em jovens e sobrediagnostica em idosos.
- 2

DVO com CVF reduzida: se CVF% – VEF1% ≥ 25, sugere DVO com aprisionamento aéreo. Se < 25, medir CPT para separar obstrutivo isolado de distúrbio combinado.
- 3

VEF1/CVF normal com CVF reduzida: "sugestivo de DVR" ou distúrbio ventilatório inespecífico (CVF baixa com CPT normal). A certeza exige CPT; sem ela, o laudo é descritivo.
- 4

Tudo normal: fluxos terminais e VEF1/CV lenta podem sugerir DVO incipiente em contexto clínico compatível. Fluxos só contam como reduzidos com CVF normal.

PRISm: termo da ERS/ATS 2022 e do GOLD para VEF1 e/ou CVF reduzidos com relação preservada, usado sobretudo em fumantes sem CPT. A SBPT 2024 não adota o termo; o equivalente é o passo 3, e a conduta é medir CPT quando clinicamente indicado.

Gravidade e broncodilatador

Quadros 7 e 8 da diretriz

Gravidade	Obstrutivo VEF1 % prev	Restritivo* CVF % prev
Leve	≥ 60	> 65 até o LIN
Moderado	41–59	51–65
Acentuado	≤ 40	≤ 50

*O diagnóstico de DVR se baseia na CPT reduzida. Se a espirometria não define o distúrbio, não se classifica a gravidade. A diretriz não adotou as faixas de escore Z da ERS/ATS 2022 para gravidade.

Prova broncodilatadora

- Salbutamol **400 µg**, nova espirometria após **15 min**.
- Ganho = (pós – pré) × 100 / valor previsto.
- Significativo: **≥7% do previsto** em exames alterados e **≥10%** em exames normais no pré-BD. Não é mais exigido ganho absoluto em mL.
- FEF25–75% e demais fluxos não entram na avaliação de reversibilidade.

Resposta ao BD não separa asma de DPOC isoladamente, e a normalização da VEF1/CVF pós-BD não exclui DPOC. Ausência de resposta não contraindica o uso clínico do broncodilatador.

Qual equação usar (Quadro 6)

3–12 anos: Jones et al. **Adolescentes:** Mallozi (13–19 anos no sexo feminino; 13–24 anos no masculino). **Adultos:** Pereira et al. 2007 (≥20 anos no feminino; ≥25 anos no masculino). A equação para adultos negros (Prata et al. 2018) fica como opção nos exames limítrofes, sempre com contexto clínico. Nos muito idosos, é correto extrapolar os valores previstos.

No laudo

Registrar peso ou IMC, equação utilizada e LIN. Comparar com exames anteriores do mesmo paciente sempre que possível. Diante de valores limítrofes, escrever "correlacionar com contexto clínico ou probabilidade pré-teste".

Fonte principal: Albuquerque ALP, Berton DC, Pereira CAC et al. Novas recomendações de espirometria da SBPT – atualização 2024. J Bras Pneumol. 2024;50(6):e20240169. Complementar: Stanojevic S et al. ERS/ATS technical standard on interpretive strategies. Eur Respir J. 2022;60:2101499. Lista completa em referencias.txt.